

TEMA 3.41 • OBSTETRICIA

Corioamnionitis / Infección Intraamniótica

PERFIL EUNACOM 1.03.41

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Corioamnionitis / Infección Intraamniótica

Concepto

Actualmente son sinónimos → misma conducta: **interrumpir + ATB de inmediato**, independiente de la EG.

Causa: Infección bacteriana polimicrobiana ascendente desde la vagina (siempre asociada a rotura de membranas — grande o pequeña).

Diagnóstico — Criterios Modernos

Criterio mayor (obligatorio): Fiebre ≥ 38°C

• **+ al menos 1 criterio menor:**

- Taquicardia fetal > 160 lpm
- Flujo purulento o fétido
- Leucocitosis > 15.000

NOTA CLÍNICA

Criterios de Gibbs (clásicos): fiebre > 37,8°C + 2 criterios menores (incluían también dolor uterino y taquicardia materna > 100, que los criterios modernos eliminaron por ser muy inespecíficos).

Tratamiento

TABLA 3.41.1: COMPONENTE VS DETALLE

COMPONENTE	DETALLE
ATB	Ampicilina + gentamicina EV
Si cesárea	Agregar cobertura anaeróbica: metronidazol o clindamicina
Interrupción	Inmediata (sin importar EG)
Vía	Vaginal de regla (corioamnionitis no indica cesárea per se)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La corioamnionitis/infección intraamniótica es **contraindicación absoluta de tocolíticos**.

Amniocentesis: ¿cuándo hacerla?

La amniocentesis se hace cuando hay **duda diagnóstica** (no cuando hay sospecha clínica clara):

TABLA 3.41.2: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS

INDICACIÓN
Clínica sugestiva pero embarazo muy prematuro (< 34 sem) y no se está convencido
Observación de una pielonefritis aguda (fiebre con otra causa posible)
Fiebre aislada sin otros criterios, < 28 semanas, sin otra causa identificada

Amniocentesis confirma infección si:

- **Leucocitos > 30/mm³** (algunas fuentes: > 50)
- **Glucosa < 15 mg/dL**
- **Cultivo o Gram (+)** para bacterias

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Corioamnionitis / Infección Intraamniótica: Diagnóstico — Criterios Modernos Criterio mayor (obligatorio): Fiebre ≥ 38°C +... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Corioamnionitis / Infección Intraamniótica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Concepto
- Diagnóstico — Criterios Modernos
- Tratamiento
- Amniocentesis: ¿cuándo hacerla?
- Amniocentesis confirma infección si:
- Actualmente son sinónimos
- interrumpir + ATB de inmediato

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CORIOAMNIONITIS / INFECCIÓN INTRAAMNIÓTICA)

PREGUNTA 1

En relación a Corioamnionitis / Infección Intraamniótica: Diagnóstico — Criterios Modernos Criterio mayor (obligatorio): Fiebre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ +... ¿cuál es la conducta correcta?

- ☐ A) El diagnóstico de Corioamnionitis / Infección Intraamniótica se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- ☐ B) El manejo inicial de Corioamnionitis / Infección Intraamniótica debe orientarse según el estado clínico del paciente
- ☐ C) Todo paciente con Corioamnionitis / Infección Intraamniótica requiere hospitalización inmediata
- ☐ D) El tratamiento de Corioamnionitis / Infección Intraamniótica es igual en todas las edades y contextos clínicos
- ☐ E) El seguimiento de Corioamnionitis / Infección Intraamniótica no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Corioamnionitis / Infección Intraamniótica?

- ☐ A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- ☐ B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- ☐ C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- ☐ D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- ☐ E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Corioamnionitis / Infección Intraamniótica. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- ☐ A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- ☐ B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- ☐ C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- ☐ D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- ☐ E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: CORIOAMNIONITIS / INFECCIÓN INTRAAMNIÓTICA

Causa: Infección bacteriana polimicrobiana ascendente desde la vagina (siempre asociada a rotura de membranas — grande o pequeña). ::::note Criterios de Gibbs (clásicos): fiebre $> 37,8^{\circ}\text{C}$ + 2 criterios menores (incluían también dolor uterino y taquicardia materna > 100 , que los criterios modernos eliminaron por ser muy inespecíficos). ::::warning La corioamnionitis/infección intraamniótica es contraindicación absoluta de tocolíticos. :::